Disfagia y Alimentación Segura al Alta: Diseño de Plan

Gabriel Salgado-Maldonado
Fonoaudiólogo.
Académico Escuela de Enfermería – Facultad de Enfermería y Obstetricia - Universidad de los Andes
Académico Escuela de Fonoaudiología – Facultad de Medicina - Universidad de los Andes
Presidente Sociedad Chilena de Deglución y Alimentación (SOCHIDA)



Declaración de interés

Declaro no tener conflicto de interés con la industria

Las tecnologías presentadas no financian esta presentación

***Salgado Lopez Holding** financia esta presentación mediante su sistema de matripuntos*



María Gracia, 2026 – Oda al Comer



Sra. Rosa, 82 años

Vive con su hija, que trabaja durante el día. Hipertensión, diabetes tipo 2 y deterioro cognitivo leve.

Fue hospitalizada 8 días por neumonía, con un episodio de delirium que ya resolvió.

Recibió quetiapina en dosis baja durante el delirium y se mantiene indicada al alta.

Ha bajado 4 kg en el último mes, la dentadura le queda suelta y tose ocasionalmente con los líquidos.

Hoy come dieta blanda y toma líquidos espesados que "le gustan poco", y a veces los rechaza**.**

.

Mañana tiene alta.

Si mañana se va a casa, ¿quién y cómo se asegura de que coma seguro?

Levanten la mano si en su institución esta paciente saldría con un plan de alimentación escrito.

¿Y si el plan incluyera cómo dar sus medicamentos?

La presbifagia reduce la reserva funcional, pero no equivale a disfagia clínica

El envejecimiento sano modifica la mecánica deglutoria; el adulto mayor suele compensar hasta que una enfermedad, un fármaco o la hospitalización superan esa reserva.

01 FASE ORAL

Preparación más lenta

Hipotonía oral, pérdida dentaria y menor sensibilidad prolongan la preparación y el control del bolo.

02 FASE FARÍNGEA

Respuesta más tardía

Reflejo deglutorio retrasado, tránsito faríngeo prolongado y coordinación más débil o lenta.

03 PRESIONES

Mayor esfuerzo compensatorio

La faringe genera presiones más altas y variables para vencer mayor resistencia en la apertura del EES.

HALLAZGOS MÁS CONSISTENTES: ↑ tiempo de tránsito del bolo + retraso en el inicio del reflejo deglutorio

Adulto mayor sano
Eficiencia global relativamente preservada

→

Menor reserva
Cambios subclínicos y compensados

→

Estrés adicional
Enfermedad aguda · fármacos · hospitalización

→

Descompensación
Aparece disfagia clínicamente significativa

Presbifagia y fisiología del envejecimiento: [1], [4], [5]

ENVEJECIMIENTO Y DEGLUCIÓN · 2/2

Fragilidad y sarcopenia convierten la menor reserva en disfagia clínicamente relevante

La relación es bidireccional: la pérdida muscular altera la deglución y la disfagia empeora nutrición, fuerza y vulnerabilidad.

FRAGILIDAD Y DISFAGIA

OR 3,45 — Prefrágiles vs. robustos

OR 7,57 — Frágiles vs. robustos
IC 95% 5,10–11,7

La asociación persiste tras ajuste; la demencia no mostró asociación significativa en ese estudio.

DISFAGIA SARCOPÉNICA

La pérdida muscular alcanza lengua, geniohioideo y faringe

- **↓ fuerza lingual** — Menor propulsión del bolo
- **↓ contracción faríngea** — Más residuo faríngeo
- **↓ desplazamiento hiolaríngeo** — Mayor penetración y aspiración
- **Reflejo retardado** — Menor seguridad de la ingesta

DO: 16% en mayores independientes de 70–79 años → hasta 60% en institucionalizados | ≈1 de cada 3 personas con disfagia presenta sarcopenia

SARCOPENIA → DISFAGIA → MENOR INGESTA / MALNUTRICIÓN → MÁS SARCOPENIA Y FRAGILIDAD

SÍNTOMAS + FRAGILIDAD/SARCOPENIA: evaluar deglución, nutrición y fuerza de prensión

Fragilidad, sarcopenia y función deglutoria: [2], [3], [6–11]

MAGNITUD DEL PROBLEMA

La disfagia orofaríngea afecta a cerca de la mitad de los ancianos hospitalizados

Su alta prevalencia y sus complicaciones convierten la pérdida de supervisión al alta en un riesgo para la continuidad del cuidado.

PREVALENCIA GLOBAL

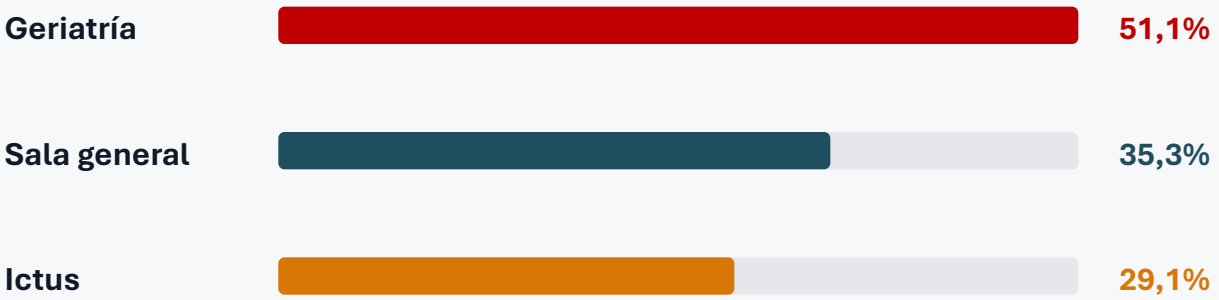
36,5%

Metaanálisis de 17 estudios hospitalarios

47,4% Ancianos frágiles con enfermedad aguda

46% Metaanálisis ≥60 años n = 31.488

VARIACIÓN SEGÚN EL CONTEXTO CLÍNICO



La prevalencia permanece alta incluso en servicios no geriátricos.

ICTUS AGUDO Y EVOLUCIÓN

40–78% en fase aguda → **11–50%** persisten a los 6 meses

FACTORES QUE AGRAVAN EL RIESGO

Antipsicóticos, benzodiazepinas, antidepresivos, opioides, anticolinérgicos y betabloqueantes.

DELIRIUM ↔ DO

ALTA SIN SUPERVISIÓN ACTIVA = MAYOR RIESGO DE ASPIRACIÓN, DESNUTRICIÓN, DESHIDRATACIÓN Y REINGRESO

2015 P. Clave - 2023. Rivelsrud MC- - 2026. Elmallahy M -2021. Banda KJ - 2021. Green TL - 2021. Wolf U

PREVALENCIA DE LA DISFAGIA OROFARÍNGEA EN EL ANCIANO

Contexto Hospitalario y Riesgo al Alta

1. VISIÓN GLOBAL: ALTA Y CONSISTENTE



HASTA
47.4%
de Ancianos Frágiles Hospitalizados



36.5%
PREVALENCIA GLOBAL
(Metaanálisis, 17 estudios)



46%
PREVALENCIA GLOBAL
(Metaanálisis, >31,000 part.)



2. VARIACIÓN POR CONTEXTO CLÍNICO

Unidades Específicas vs. Generales



GERIATRÍA: **51.1%**
GERIATRÍA



GENERAL: **35.3%**
GENERAL



ICTUS: **29.1%**
ICTUS

Ictus Agudo & Evolución



AGUDO:
40% - 78%

A LOS 6 MESES
11% - 50%



3. EL PUNTO CRÍTICO: ALTA HOSPITALARIA

Constituye un **riesgo real** para la continuidad del cuidado, porque sus consecuencias dependen de una supervisión activa que desaparece al dejar el hospital.







NEUMONÍA ASPIRATIVA



DESNUTRICIÓN OATMEAL



DESHIDRATACIÓN



REINGRESO

2015 P. Clave - 2023. Rivelsrud MC- - 2026. Elmallahy M -2021. Banda KJ - 2021. Green TL - 2021. Wolf U

Infografía elaborada por Gemini

IMPACTO CLÍNICO

La disfagia inicia una cascada que duplica complicaciones y casi triplica la mortalidad

La DO no es un hallazgo aislado: compromete seguridad respiratoria, estado nutricional, supervivencia y continuidad del cuidado.

OR 2,07

Neumonía aspirativa

· **IC 95% 1,58–2,72**

La aspiración confirmada por videofluoroscopia ocurre en 43–51% de las personas con disfagia.

OR 2,21

Desnutrición y deshidratación

· **IC 95% 1,43–3,41**

La deglución ineficaz compromete directamente la ingesta de líquidos y nutrientes.

OR 2,73

Mortalidad

· **IC 95% 1,62–4,60**

El riesgo de muerte aumenta en presencia de disfagia.



Reingreso e institucionalización

Mayor estancia, costos y altas no rutinarias

La asociación persiste incluso sin fragilidad y aumenta las complicaciones médicas y la institucionalización.

ASPIRACIÓN → DETERIORO NUTRICIONAL → MAYOR MORTALIDAD → REINGRESO / INSTITUCIONALIZACIÓN

2021. Banda KJ, 2021. Green TL, 2021. Wolf U, 2021. Chen S,

TRANSICIÓN DEL CUIDADO

El alta es el punto crítico: la supervisión se pierde antes de asegurar la continuidad

La mejoría hospitalaria no garantiza una deglución segura en domicilio si la transición es fragmentada y no existe reevaluación programada.

DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN

Red multidisciplinaria activa

Enfermería · Fonoaudiología · Nutrición · Medicina

- Ajuste de dieta y líquidos
- Supervisión de la ingesta
- Vigilancia de aspiración
- Respuesta inmediata ante cambios

ALTA

BRECHA SISTÉMICA

La supervisión se pierde de forma abrupta

DESPUÉS DEL ALTA

Transición inconsistente y fragmentada

- Acceso variable a reevaluación
- Comunicación clínica incompleta
- Indicaciones contradictorias o innecesarias
- Familias sin preparación para sondas o cambios

Consecuencia: se mantienen recomendaciones sin comprender su base fisiológica, se duplican evaluaciones y puede retrasarse la recuperación deglutoria.

EL ALTA DEBE INCLUIR UN PLAN EXPLÍCITO DE DEGLUCIÓN

- Estado deglutorio
- Riesgo de aspiración
- Dieta y ruta
- Hidratación
- Signos de alarma
- Reevaluación

2026. Bonilha HS / 2026. Xia J

Un alta segura comienza con documentación que pueda ejecutarse

El plan debe convertir los hallazgos clínicos en instrucciones comprensibles, justificadas y trazables.

1 · RESUMEN CLÍNICO DE DEGLUCIÓN

Qué sabemos al momento del alta

1 **Evaluación clínica**
Resultados de fonoaudiología y nivel de severidad.

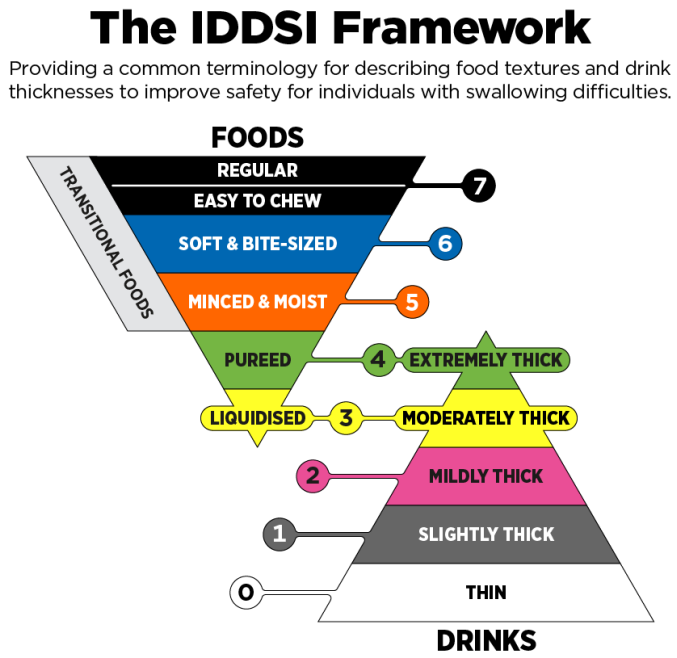
2 **Evaluación instrumental**
Hallazgos de VFSS o FEES, si se realizaron.

3 **Riesgo actual**
Aspiración, eficiencia deglutoria y factores que aumentan el riesgo.



Un alta segura comienza con documentación que pueda ejecutarse

El plan debe convertir los hallazgos clínicos en instrucciones comprensibles, justificadas y trazables.



2 · PRESCRIPCIÓN OPERATIVA

Qué debe hacer el paciente y por qué

4 **Dieta y líquidos**

Nivel IDDSI y justificación fisiológica de la restricción.

5 **Ruta de alimentación**

Oral, oral con suplementación o enteral; indicar si es temporal*.

6 **Signos de alarma**

Tos, fiebre, pérdida de peso o deshidratación: cuándo consultar.

NO BASTA CON INDICAR QUÉ HACER: DEBE QUEDAR ESCRITO POR QUÉ, DURANTE CUÁNTO TIEMPO Y CUÁNDO REEVALUAR

Mejores prácticas posthospitalarias en disfagia post-ictus [1]

PLAN DE ALTA · 2/3

La alimentación debe planificarse como una ruta dinámica, no indefinida

La vía elegida debe responder al riesgo actual y contener criterios para avanzar, suplementar o retirar soporte enteral.

RUTA DE ALIMENTACIÓN AL ALTA

01 Oral exclusiva

Dieta y líquidos con nivel IDDSI definido y estrategias de seguridad.

02 Oral + suplementación

Mantener ingesta segura y cubrir requerimientos nutricionales e hídricos.

03 Enteral

SNG o gastrostomía con objetivo, duración esperada y criterios de revisión.

La alimentación enteral no debe mantenerse por inercia: documentar si es temporal, qué recuperación se espera y qué hallazgos permitirán modificarla o retirarla.

Cuidado oral

Higiene oral domiciliaria como medida modificable del riesgo de neumonía.

Hidratación

Plan concreto para alcanzar líquidos suficientes dentro de la consistencia segura.

Nutrición

Evaluación dietética y monitorización de peso, desnutrición y dependencia enteral.

PLAN DE ALTA · 3/3

El seguimiento convierte la indicación de alta en continuidad real

La recuperación deglutoria puede continuar: la reevaluación debe programarse y conectarse con todos los niveles de atención.

CALENDARIO DE REEVALUACIÓN



Estado basal

Dieta, ruta, riesgo y objetivos documentados.

Control clínico

Revisar tolerancia, hidratación, peso y adherencia.

VFSS / FEES

Ajustar restricciones y soporte con imagen deglutoria.

Reevaluación urgente

Tos, fiebre, pérdida de peso o deshidratación.

Paciente y cuidador

Explicar que la recuperación continúa y entrenar el manejo seguro de sondas, dieta y alarmas.

Comunicación entre niveles

Transferir evaluación, imagen, recomendaciones y objetivos; evitar depender solo del reporte verbal.

Sistema de atención

Hacer de la reevaluación un componente esperado, independientemente del destino o los recursos.

Brecha actual: las guías estandarizan el cribado y diagnóstico agudo, pero el seguimiento a largo plazo sigue poco definido y con consenso limitado.

HERRAMIENTA CONCRETA · ALTA

La hoja de alta IDDSI obliga a completar lo que hoy queda ambiguo

Adaptación de su pauta clínica: conserva seguridad, postura e higiene; reemplaza etiquetas ambiguas por niveles y pruebas IDDSI.

HOJA DE ALTA · CAMPOS MÍNIMOS ANTES DEL EGRESO

01 Prescripción

Vía: oral / mixta / enteral
Alimentos IDDSI: __ (3–7)
Líquidos IDDSI: __ (0–4)

02 Ejecución segura

Alerta + sentada/o a 90° · sin distractores
Utensilio, volumen y ritmo
Supervisión + maniobra indicada

03 Cierre del circuito

Higiene oral y fármacos
Alarmas + contacto
Control: fecha, lugar y responsable

No usar “néctar / miel / pudding” ni “blando” como única indicación: escribir número + nombre IDDSI y confirmar con el método de prueba correspondiente.

Paciente y cuidador

Recibe copia simple y demuestra preparación, postura y administración antes del alta.

Equipo interdisciplinario

Fonoaudiología prescribe; Nutrición operacionaliza menú e hidratación; Enfermería refuerza y observa.

Seguimiento

Registrar insumos, responsable diurno, metas y criterios explícitos de reevaluación.

Hoja de Alta

Plan de alimentación y deglución al alta

Indicaciones para la persona y quienes la acompañan. El profesional completa y explica este plan según la evaluación. Aplicar solo las opciones marcadas.

Nombre _____ Fecha _____ Cuidador/a _____

1 Vía de alimentación y ayuda necesaria

□ Oral exclusiva □ Oral y apoyo por sonda □ Solo sonda u ostomía □ Otro plan: _____

Por boca se permite: □ Alimentos □ Líquidos □ Medicamentos □ Nada por boca

Apoyo: □ Independiente □ Supervisión □ Asistencia completa Responsable: _____

Si usa sonda u ostomía, adjuntar plan de nutrición, agua, medicamentos y cuidados del dispositivo.

2 Alimentos y líquidos indicados

Alimentos: nivel IDDSI _____ Textura _____ Ejemplos _____

Líquidos: nivel IDDSI _____ Consistencia _____ Bebidas permitidas _____

Si requiere espesante: producto _____ Cantidad _____ por _____ mL Espera _____ min

Preparación y verificación enseñadas: _____

Meta diaria de líquidos definida por el equipo: _____ mL Vía(s): _____ Registro a cargo de: _____

Suplemento y horario, si corresponde: _____

3 Durante la alimentación por boca

Ofrecer solo cuando esté despierto/a y atento/a. Si se duerme o pierde la atención, detener la ingesta. Acomodar el cuerpo con apoyo y reducir distractores. Respetar su ritmo y no forzar.

Postura indicada _____ Tiempo en esa posición después _____

Volumen por bocado o sorbo _____ Utensilio _____ Bombilla: □ Sí □ No □ No indicada

Maniobra o estrategia entrenada _____ □ No requiere maniobras

4 Higiene oral y medicamentos

Cepillar dientes, encías y lengua al menos dos veces al día. Limpiar las prótesis y retirar restos después Mantener higiene oral aunque no coma por boca; usar la técnica enseñada.

Apoyo o adaptación para higiene oral: _____

Medicamentos: seguir la pauta adjunta revisada por medicina o farmacia. No triturar, abrir cápsulas r espesante sin confirmación para cada medicamento.

5 Cuándo detener la ingesta y pedir ayuda

Detener la ingesta ante atoros, tos repetida, voz húmeda nueva o somnolencia. Contactar al equipo s aparecen en forma repetida. La ausencia de tos no garantiza una deglución segura.

Consultar el mismo día por fiebre, menor ingesta, poca orina, rechazo persistente de líquidos o deter Solicitar reevaluación por pérdida de peso o comidas cada vez más prolongadas.

Emergencia: si no puede respirar, hablar o toser, o pierde la conciencia, activar el servicio de urgen

6 Seguimiento y verificación antes de salir

Próximo control: fecha _____ Profesional/centro _____ Contacto _____

Objetivo de reevaluación o cambio del plan: _____

□ Persona/cuidador demuestra preparación y ayuda □ Comprende alarmas □ Cuenta con insumos

Preferencias y acuerdos con la persona: _____

Fonoaudiólogo/a _____ Firma _____ Contacto _____

CIERRE · CASO ROSA

Rosa solo debería egresar con un plan ejecutable y supervisión asegurada

“Dieta blanda + espesados” no basta: el plan debe resolver seguridad, aceptación, nutrición, medicamentos y apoyo diurno.

PLAN DE ALTA INDIVIDUALIZADO

ANTES DEL ALTA

Confirmar y documentar

Definir niveles IDDSI, estrategias y administración segura de fármacos.

EN CADA INGESTA

Supervisión activa

Sentada a 90°, ritmo lento, bocados pequeños, higiene oral y no comer sola.

CONTROL PRECOZ

Nutrición y tolerancia

Revisar hidratación, peso, rechazo de espesados y necesidad de suplementación.

ANTE DETERIORO

Consulta urgente

Más tos o atoros, voz húmeda, fiebre, disnea, somnolencia o baja ingesta.

Cuidador y entorno

La hija trabaja: coordinar apoyo diurno y verificar demostración práctica antes del alta.

Riesgos modificables

Revisar quetiapina, ajustar prótesis dental y reforzar higiene oral.

Continuidad

Entregar plan escrito y dejar controles de fonoaudiología, nutrición y medicina agendados.

CRITERIO DE ALTA: cuidador entrenado + plan escrito + insumos disponibles + seguimiento programado

Síntesis aplicada del marco de alta segura al caso Rosa · Ejercicio docente

Disfagia y Alimentación Segura al Alta: Diseño de Plan

Gabriel Salgado-Maldonado
Fonoaudiólogo.
Académico Escuela de Enfermería – Facultad de Enfermería y Obstetricia - Universidad de los Andes
Académico Escuela de Fonoaudiología – Facultad de Medicina - Universidad de los Andes
Presidente Sociedad Chilena de Deglución y Alimentación (SOCHIDA)

